

HIPOSFAGMA O EQUIMOSIS SUBCONJUNTIVAL

Ana Garrote Llordén, Marta Cuesta Lasso, Andrea Carrancho García.

INTRODUCCIÓN

Se trata de una colección de sangre bajo la conjuntiva debida a la rotura de un vaso sanguíneo. Observamos una mancha roja o violácea que no deja ver los vasos ni la esclera subyacentes.

El hiposfagma es idiopático en la mayoría de los casos. Puede estar relacionado con maniobras de Valsalva, enfermedades sistémicas como hipertensión arterial (HTA) o alteraciones hematológicas. En ocasiones puede ser secundario a un traumatismo (a menudo inadvertido), una cirugía o una conjuntivitis, principalmente de origen vírico. En pacientes jóvenes es común su asociación con el uso de lentes de contacto.

DIAGNÓSTICO

Se trata de una patología habitualmente asintomática, sin dolor ni alteración en la agudeza visual. Puede aparecer sensación de cuerpo extraño si la colección hemática es grande y condiciona una sobreelevación de la conjuntiva.

El diagnóstico es clínico, se basa en la anamnesis y la exploración ocular. No requiere la realización de otras pruebas. Sólo en casos de repetición está indicado el estudio de coagulación (también debe realizarse en pacientes anticoagulados), glucemia y tensión arterial, de forma ambulatoria. Ante la aparición de hiposfagma en niños pequeños hay que tener en cuenta su posible asociación con déficit de vitamina C o con maltrato.

TRATAMIENTO EN URGENCIAS

El hiposfagma no requiere tratamiento, se resuelve espontáneamente en días o semanas. En caso de sensación de cuerpo extraño se recomienda el uso de lubricantes de superficie ocular.



Etiología y curso clínico de los hiposfagmas

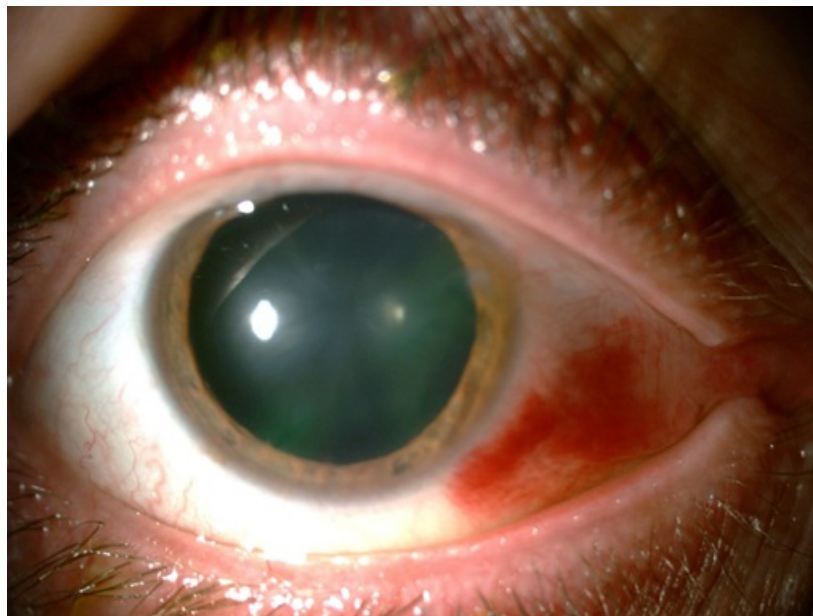


Imagen 2.- Hiposfagma nasal inferior tras traumatismo. Midriasis farmacológica.

BIBLIOGRAFÍA

- Kanski JJ, Bowling B. Clinical Ophthalmology, A Systematic Approach. 8ª ed. Sydney: Saunders Ltd.; 2015.
- Maldonado López JM, Pastor Jimeno JC; Guiones de oftalmología: aprendizaje basado en competencias. 2ª ed. Madrid: McGraw-Hill Interamericana; 2011.
- Ehlers JP, Shah CP. *The Wills Eye Manual: Office and Emergency Room Diagnosis and Treatment of Eye Disease*. 5ª ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2008.